

РАК ПИЩЕВОДА

УДК:616.329-006-036.22

Е.Ш. Абзалбек, А.Е. Ажмагамбетова, Г.Т. Сейсенбаева

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

**Эпидемиология рака пищевода по Республике Казахстан
за 2006-2015 годы**

Аннотация. Рак пищевода занимает 10-е место в структуре онкопатологии по республике. Ежегодно в Республике Казахстан регистрируются более 1300 случаев рака пищевода, около 1000 больных умирают от данного вида злокачественного новообразования.

Цель исследования: изучение заболеваемости населения Республики Казахстан раком пищевода за 10 лет, с 2006 по 2015 годы с целью проведения целенаправленной организации противораковой борьбы.

Материалы и методы. В процессе исследований обработаны данные всех зарегистрированных больных раком пищевода в Республике Казахстан с 2006-2015 гг. Изучение динамики заболеваемости раком пищевода отдельно мужского и женского населения проведено в десятилетних временных и возрастных интервалах.

Использованы статистические данные Агентства Республики Казахстан о численности, половозрастном и национальном составе населения по регионам республики. При стандартизации заболеваемости использован прямой метод и применен мировой состав населения.

Результаты и выводы. За изучаемый период в Республике Казахстан (РК) доля рака пищевода в структуре всех злокачественных новообразований составила 2,3%. Интенсивные показатели заболеваемости раком пищевода населения РК за 10 лет свидетельствуют, что в динамике эти показатели имели тенденцию колебания с 9,3‰ (2006г.) до 9,6‰ в 2007 году, начиная с 2007 года наблюдается тенденция снижения до 7,7‰ в конце исследования.

Лидирующая позиция по заболеваемости раком пищевода установлена в Кызылординской (17,2‰) и Западно-Казахстанской (17,1‰) областях. Ряд высоких показателей отмечены в Актыбинской (13,1‰), Атырауской (12,2‰), Мангистауской (11,5‰) областях.

Наиболее низкие показатели заболеваемости раком пищевода отмечены в городах Алматы (4,4‰) и Астана (4,9‰),

Алматинской (5,8‰) и Южно-Казахстанской (6,8‰) областях и ряде областей северного региона РК.

Ключевые слова: рак пищевода, заболеваемость, смертность, интенсивные показатели заболеваемости и смертности.

Рак пищевода занимает 10-е место в структуре онкопатологии в 2015 году. Рак пищевода (РП) входит в пятерку наиболее частых причин смерти среди онкологических больных. У 900 тыс. умерших он является основной причиной смерти [1,2].

За 10-летний период исследования в РК зарегистрировано 13354 больных раком пищевода, что составляет в структуре злокачественных опухолей 2,3% [3,4].

Анализ среднегодовых интенсивных показателей заболеваемости раком пищевода в РК за различные возрастные группы в динамике за изучаемый период показал, что данные показатели имели тенденцию к росту. Среди лиц 00-29 лет заболеваемость, как у мужчин, так и у женщин не зарегистрирована. В возрастных группах 30-39 лет за 10 лет в среднем показатели заболеваемости выросли с 0,4‰ до 0,6‰. В возрастной группе 40-49 лет данные показатели составили: среди женского населения – 2,6‰, у мужчин – 4,4‰, и у обоих полов – 3,5‰. Показатели заболеваемости раком пищевода среди лиц 50-59 лет выросли с 9,1‰ до 22,9‰. Заметный рост заболеваемости раком данной локализации в РК зарегистрирован среди лиц 60-69 лет: у мужского населения – 65,7‰, среди женщин – 32,4‰ на 100 тыс. населения.

Высокая заболеваемость раком пищевода наблюдается среди лиц в возрастной группе 70 лет и старше – 75,2‰, данный показатель заболеваемости среди мужского населения составил 102,1‰, а у женщин 61,9‰.

Повозрастные показатели заболеваемости раком пищевода мужского и женского населения РК за указанный период исследования выросли с увеличением возраста населения. Пик заболеваемости отмечался у всего населения в возрастных группах 60-69 лет и 70 лет и старше, с бимодальным характером роста (рисунок 1).

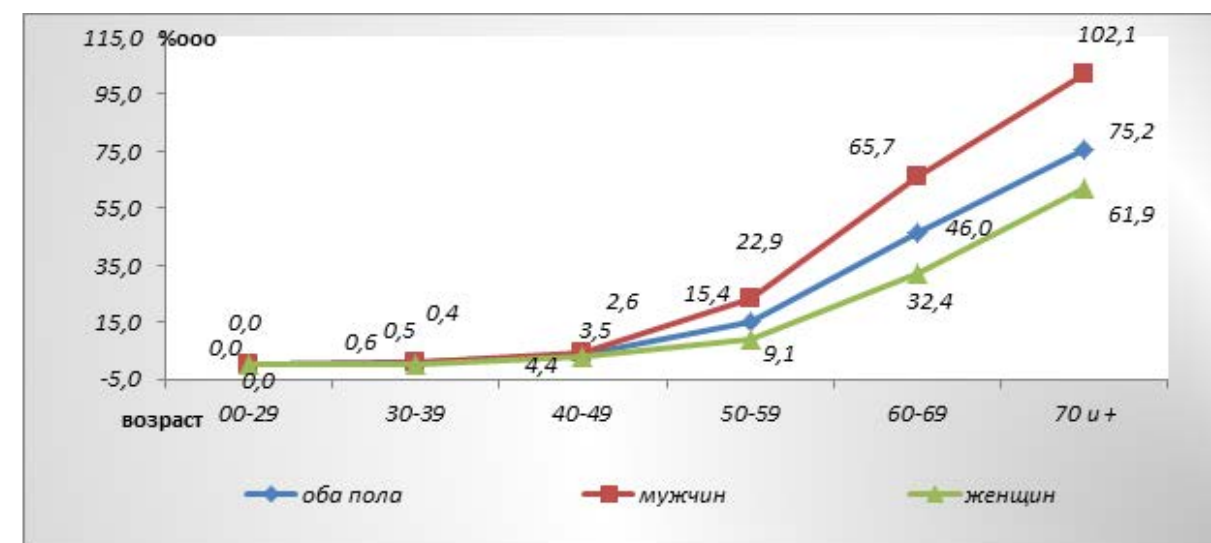


Рисунок 1 - Среднегодовые половозрастные интенсивные показатели заболеваемости раком пищевода населения РК в 2006-2015 годах

Интенсивные показатели заболеваемости раком пищевода населения РК за 10 лет свидетельствуют, что в динамике эти показатели имели тенденцию колебания с 9,3‰ (2006г.) до 9,1‰ в 2007 году, в конце исследования данный показатель составил 7,7‰ (рисунок 2).

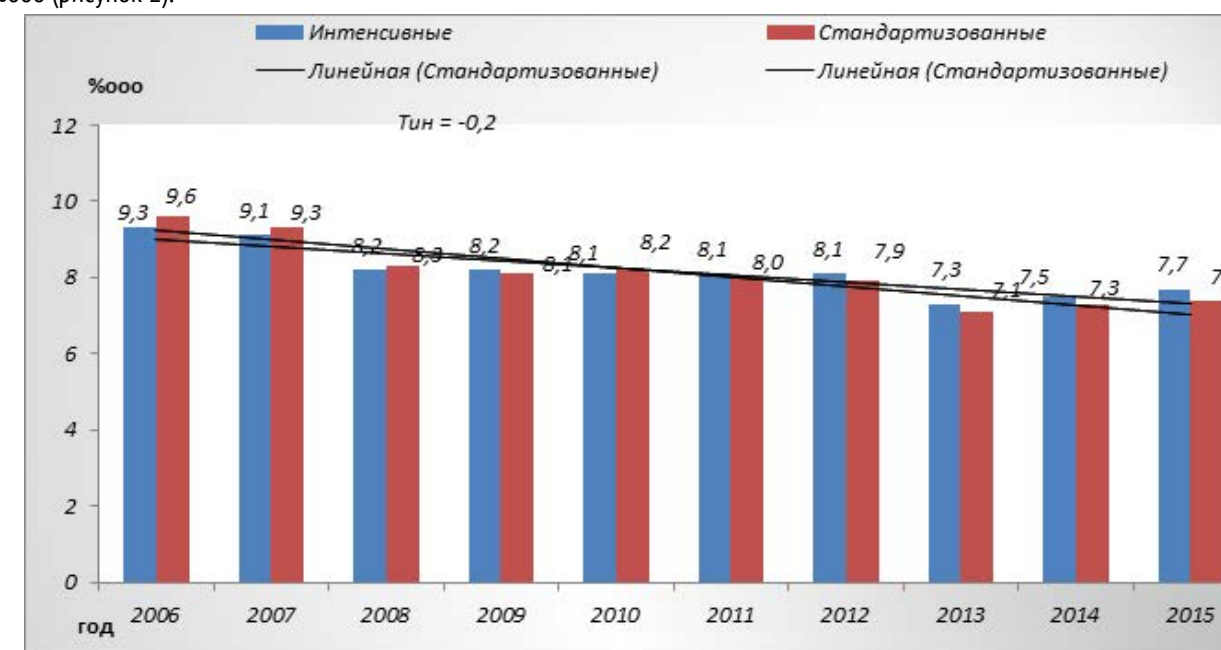


Рисунок 2 – Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости раком пищевода населения РК за 2006-2015 годы

Динамика интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости раком пищевода мужского населения за изучаемый период имеет тенденцию снижения. Период исследования завершился со значением показателя 9,0‰ в 2015 году по сравнению с началом исследования (10,3‰ - 2006 г.) (рисунок 3). Темпы интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости не совпадают. Возрастная структура населения республики не соответствует мировому стандарту.

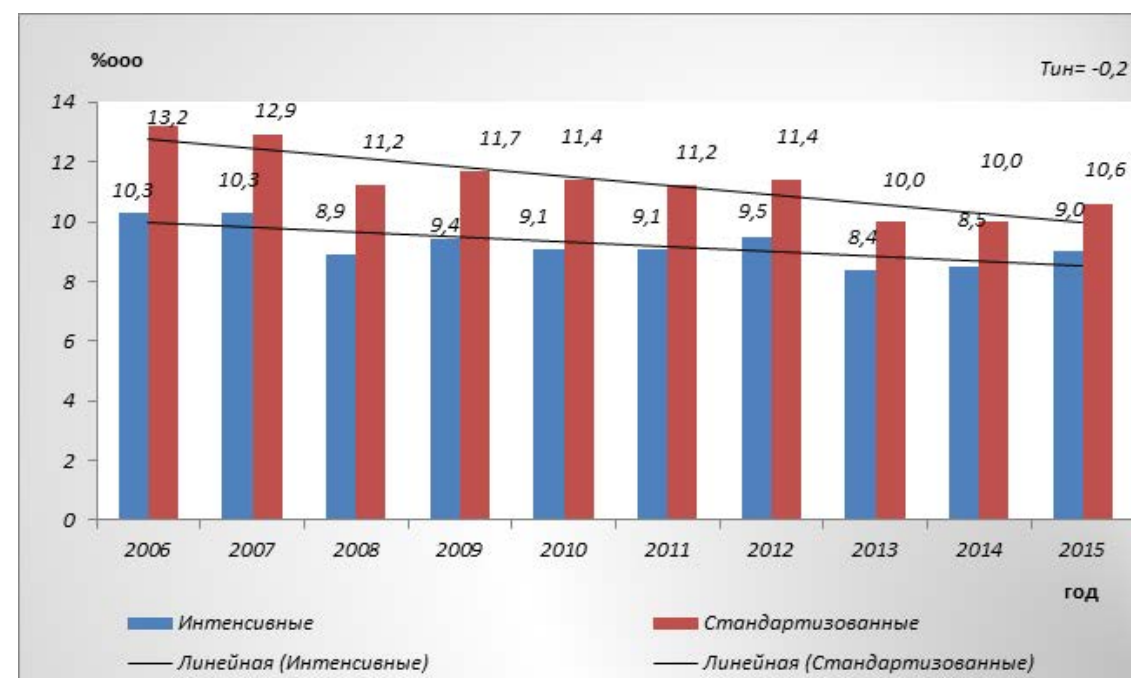


Рисунок 3 – Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости раком пищевода мужского населения РК за 2006-2015 годы

Среди женского населения за 2006-2015 годы отмечено снижение показателей с 8,5‰ в начале периода до 6,5‰ в конце исследования (рисунок 4). Темпы интенсивных и стандартизованных показателей совпадают.

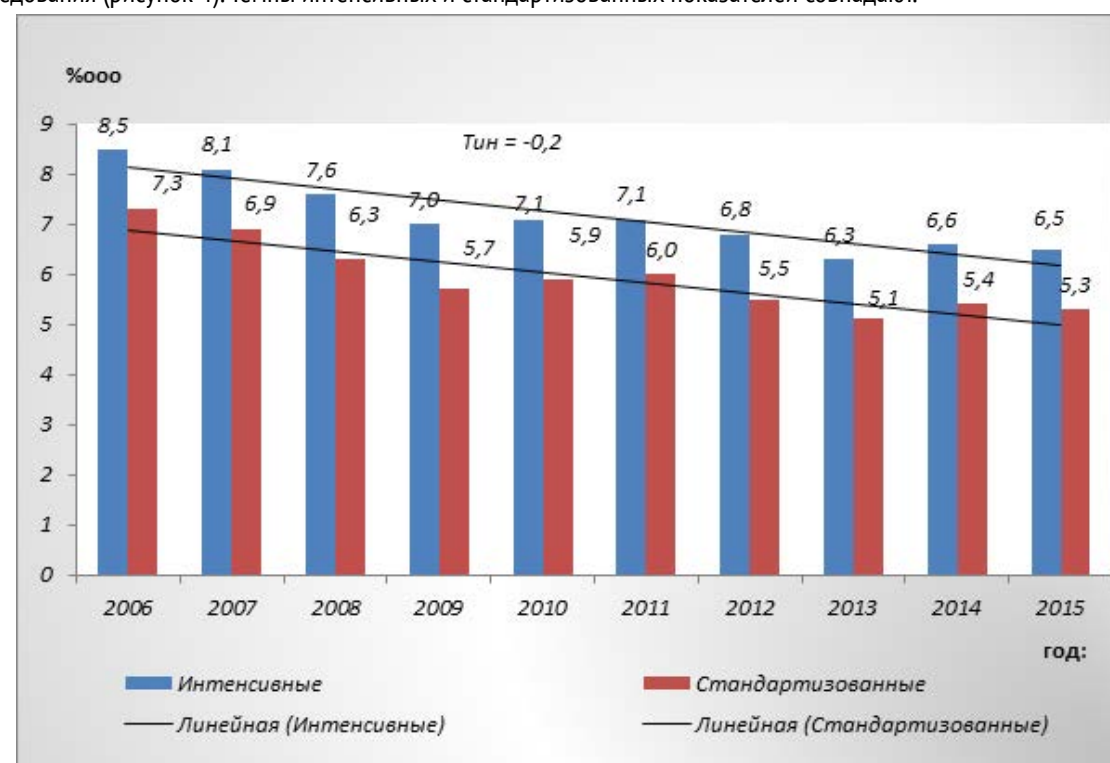


Рисунок 4 – Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости раком пищевода женского населения РК за 2006-2015 годы

Высокие показатели удельного веса рака пищевода среди всего населения РК (рисунок 5) имели характер роста по всем возрастным группам. Показатель удельного веса в возрастной группе 60-69 лет у мужчин был выше (32,8%), чем у женщин (28,1). Пик отмечен в возрастной группе 70 лет и старше у женского населения (52,1%), у мужчин удельный вес в данной возрастной группе составил 35,5%.

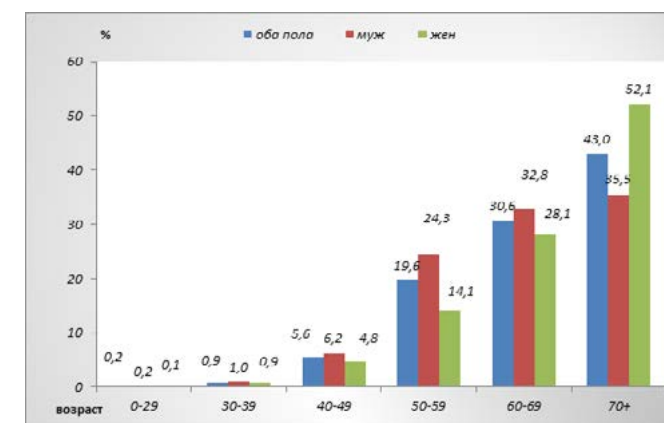


Рисунок 5 – Удельный вес рака пищевода по возрастным группам населения РК за 2006-2015 годы

Общий среднегодовой интенсивный показатель заболеваемости раком пищевода в РК составил $8,2 \pm 0,2$ ‰ при стандартизованном (мировом) уровне в $8,1 \pm 0,3$ ‰.

Выводы: Лидирующая позиция по заболеваемости раком пищевода установлена в Кызылординской (17,2‰) и Западно-Казахстанской (17,1‰) областях. Ряд высоких показателей отмечены в Актыбинской (13,1‰), Атырауской (12,2‰), Мангистауской (11,5‰) областях.

Наиболее низкие показатели заболеваемости раком пищевода были отмечены в городах Алматы (4,4‰) и Астана (4,9‰), Алматинской (5,8‰) и Южно-Казахстанской (6,8‰) областях и ряде областей северного региона РК (рисунок 6).

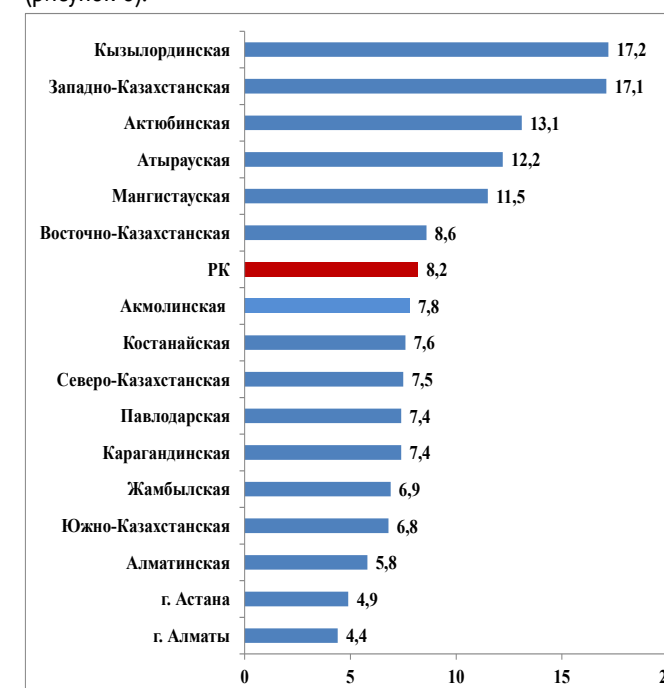


Рисунок 6 – Среднегодовые показатели заболеваемости раком пищевода по областям РК за 2006-2015 годы

Возрастные особенности распространения рака пищевода в РК за исследуемый период характеризовались тем, что в динамике уровень заболеваемости имеет тенденцию к росту в возрастных группах 60-69 лет и 70 лет и старше и носит бимодальный характер роста.

Анализ заболеваемости населения РК за 10 лет (2006-2015гг.) с учетом возрастно-половых особенностей показал, что в динамике по годам исследования уровень заболеваемости зависел от возрастного состава населения, т.е. частота заболеваемости раком пищевода росла пропорционально возрасту.

В данной работе мы не рассматривали этнический состав населения РК, хотя этнический фактор имеет определенное влияние на частоту возникновения некоторых форм рака, особенно, рака пищевода, среди жителей Казахстана. Региональные различия обуславливают особенности характера питания населения в силу различия обычаев, привычки особенностей быта населения, проживающих в отдельных регионах РК. Данные отличия, несомненно, влияют на частоту возникновения рака пищевода. Частота рака пищевода выше в тех регионах, где преимущественно потребляют пищу, богатую крахмалом (хлеб, картофель, мучные продукты), и недостаточно животных белков, молока, свежих овощей и фруктов. Демографические изменения населения, его региональные различия являются основными факторами влияющих на уровень заболеваемости населения злокачественными опухолями в целом, и в частности при раке пищевода в Казахстане.

Список литературы

1. Чиссов В.И., Давыдов М.И. Онкология: национальное руководство: М:ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 592 с.
2. Peto R. The causes of cancer // ECCO. – 1999. – Vol. 446. – S125.
3. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2006-2009 гг. (статистические материалы). – Алматы, 2007-2010 гг.
4. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеисов Д.М. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2010-2014 гг. (статистические материалы). – Алматы, 2011-2015 гг.

ТҰЖЫРЫМ

**Е.Ш. Абзалбек, А.Е. Ажмагамбетова,
Г.Т. Сейсенбаева**

Қазақ онкология және радиология ғылыми-
зерттеу институты Қазақстан Республикасының

**2006-2015 жж аралығындағы өңештің
қатерлі ісігінің эпидемиологиясы**

Қатерлі ісіктер құрылымында өңештің қатерлі ісігі (ӨҚІ) 10-ы орында тұр. Елімізде жыл сайын 1300-ге жуық өңештің қатерлі ісігі тіркеледі, 1000-ға жуық науқас осы дерттен көз жумады.

Зерттеудің мақсаты: Қазақстан халқының 10 жыл мерзімі ішінде ӨҚІ-не шалдығуын анықтау.

Осы зерттеу кезеңінде бүкіл қатерлі ісіктердің ішінде өңеш қатерлі ісігінің алатын үлесі 2,3%-ды құрады. Динамикада ӨҚІ-нің интенсивті көрсеткіштерінде ауытқулар болып, 9,3%000-ден (2006ж.) 2007 жылы 9,6%000-ге дейін, ал зерттеу уақытының соңында 7,7%000-ді құрады.

Алдыңғы орындарда Қызылорда (17,2%000) және Батыс Қазақстан (17,1%000) облыстары анықталды.

Ал төменгі көрсеткіштер Алматы (4,4%000) мен Астана (4,9%000) қалаларында, сонымен қатар Алматы (5,8%000), Оңтүстік Қазақстан (6,8%000) және еліміздің бірқатар солтүстік аймақтарында тіркелді.

Түйінді сөздер: өңештің қатерлі ісігі, ауруға шалдығу, интенсивті көрсеткіштер.

SUMMARY

**E.Sh. Abzalbek, A.E. Azhmagambetova,
G.T. Seysenbayeva**

Kazakh institute of Oncology and Radiology

**Epidemiology of esophageal cancer in the
Republic of Kazakhstan in 2006-2015**

Esophageal cancer ranks 10 among cancer pathologies. Kazakhstan has registered more than 1,300 cases of esophageal cancer each year and about 1,000 deaths from this type of cancer.

Keywords: esophageal cancer, morbidity, mortality, intensive indicators.



**Regional IGCS
Meeting**
5-6 Oct. 2017
Almaty, Kazakhstan

**Kazakh Institute of oncology and radiology invites
you to participate in the workshop conducted
jointly with IGCS and support by leading
international collaborating organizations like
ESMO, WHO and NCI.**

